



החייאת מבוגר - CPR

Cardio Pulmonary Resuscitation

חיל הרפואה. בשבילך.



מהו דום לב?



**הפרעה בפעילות החשמלית
או המכנית של הלב
שגורמת לו להפסיק לפעום**



גורמי סיכון



**יתר שומנים בדם
(כולסטרול גבוה)
לא מטופל**



עלייה בגיל



**סוכרת
לא מטופלת**



**יתר לחץ דם
לא מטופל**



עישון

מונחי יסוד



דום לב

הפסקת פעילות הלב
התקינה עקב הפרעה
חשמלית או מכאנית



מוות קליני

העדר פעילות לבבית
ונשימתית - מצב הפיך!



מוות מוחי

היעדר פעילות מוחית
- מצב בלתי הפיך!



4-6 דקות מתחילת דום הלב



בטיחות Safety



בטרם תחילת הטיפול, עלינו לוודא את בטיחות המטפל והמטופל:

1. שמירה על ביטחוננו האישי
2. הרחקת המטופל מאזור הסכנה
3. קריאה לכוחות הצלה נוספים במידת הצורך (משטרה, כבאות, חברת חשמל וכו')



שרשרת ההישרדות



טיפול
בבית
החולים

החייאה
מתקדמת

מתן
שוק
חשמלי

החייאה
בסיסית
איכותית

קריאה
לעזרה

בדיקת הכרה



נחלק מההתרשמות המהירה מסימני חיים נבצע בתחילה בדיקת הכרה:

▪ **Voice - מילולית:** יש לקרוא אל המטופל בשמו/ "אדוני..אדוני.."

▪ **Pain - פיזית:** צביטת המטופל בשרירי הטרפזים



קריאה לעזרה



יש להזעיק עזרה נוספת ברגע שמזוהה דום הלב!

הבאת
דפיברילטור
בהקדם

כוחות
רפואה
נוספים

מד"א

ביצוע עיסויים

בדיקת דופק
ונשימה

הזעקת עזרה

בדיקת הכרה

בטיחות

בדיקת דופק ונשימה



בדיקת נשימה:

תבצע ע"י הנחת יד על ביהח"ז עד כ- 10 שניות (יש/אין)

- מטופל **נושם** = הטיית ראש לאחור (Head Tilt) ושמירה על נתיב אוויר
- מטופל שאינו **נושם** - וודא האם יש/ אין דופק והמשך בסכמה
- במידה ויש **דופק ללא נשימה**, יש לשמור על נתיב אוויר ולבצע הנשמות.
- לבדוק דופק לאחר כל 2 דקות
- נשימות אגונאליות – מטופל לא נושם

מטופל נושם = ליבו הולם



דפיברילציה



מכשיר אוטומטי הנותן שוק חשמלי בעת קיום הפרעות בקצב הלב על מנת להחזיר את הקצב לתקין

מיועד להפעלה על ידי כל אדם - אין צורך בידע/רקע או ניסיון

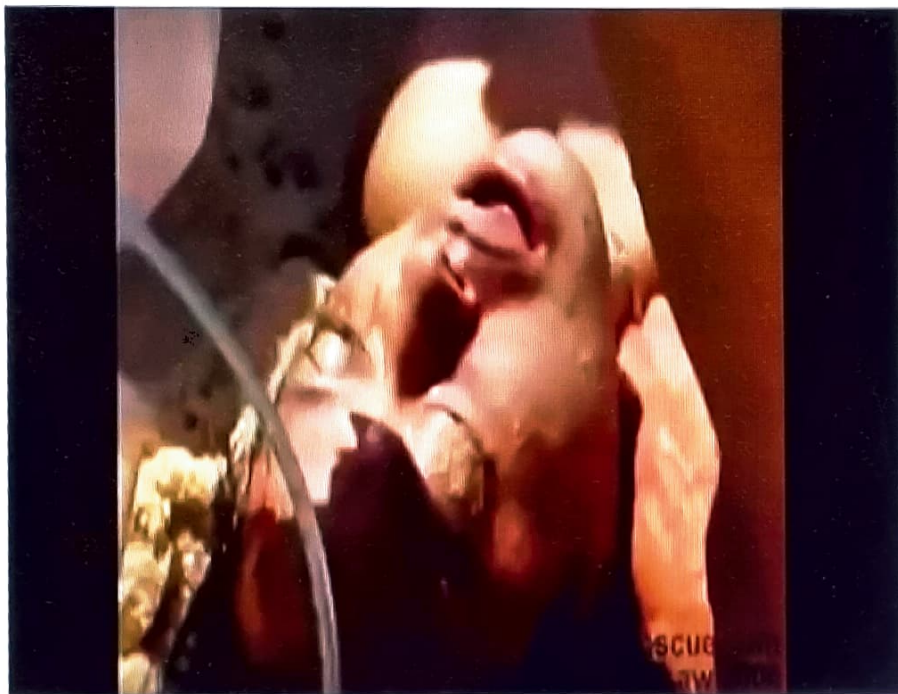
יש לחבר דפיברילטור **כמה שיותר מוקדם**, עם הפרעה קטנה ככל האפשר לרצף העיסויים

בזמן ביצוע ה"אבחון" ומתן השוק, יש **להתרחק מהמטופל** ואין לגעת בו!

ברגע שהדפיברילטור טען שוק, על המטפל **ללחוץ על כפתור השוק - המכשיר לא נותן שוק אוטומטית**



נשימות אגונאליות



בדיקת דופק ונשימה



בדיקת דופק:

■ התרשמות מקיום דופק בעורק הקרוטידי עד כ- 10 שניות (יש/אין)

■ בהיעדר דופק = **התחלת עיסויים**

בנוכחות דופק =

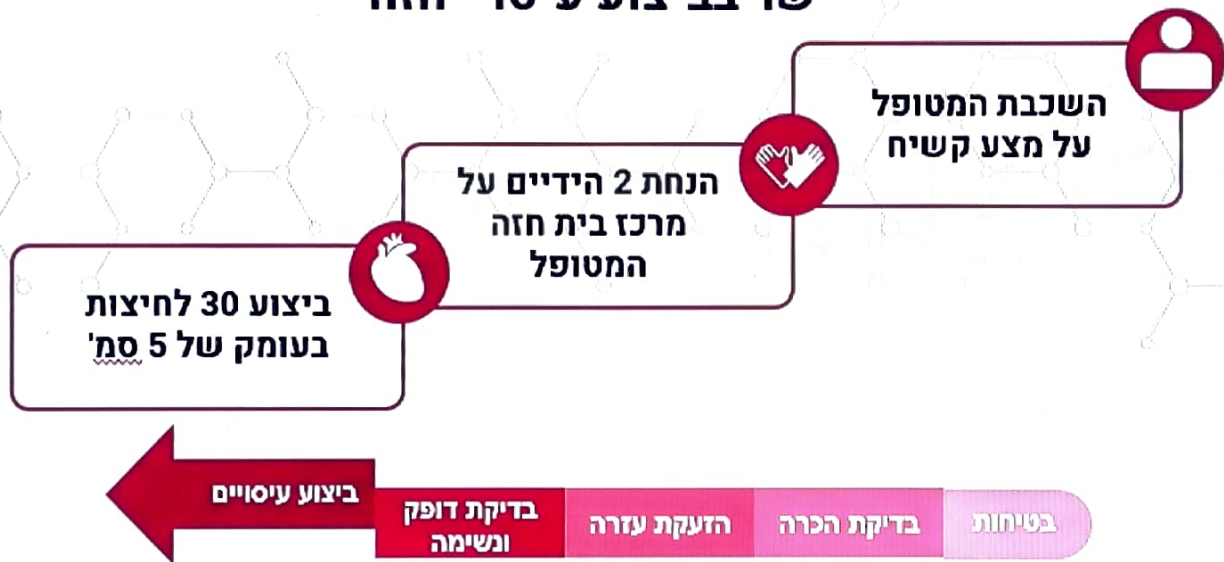
פתיחת נתיב אוויר והנשמה בכל 5 שניות, וודא דופק בכל 2 דקות



ביצוע עיסויים

במטופל ללא סימני חיים (ללא דופק או נשימה) יש להתחיל

ישר בביצוע עיסויי חזה



ביצוע עיסויים - דגשים



הפעלת הדפברילטור



1. **הדלקה** + **גילוח מהיר** בחזה שעיר (יש סכין במכשיר!) + **ניגוב** בית החזה ממים, הזעה

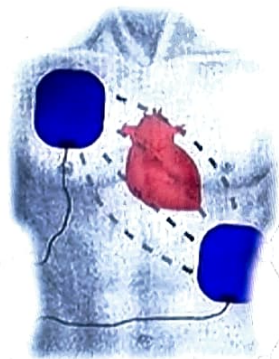
2. **חיבור המדבקות** על חזה ימין ומתחת לזרוע שמאל של המטופל

מבלי לפגוע ברצף העיסויים!

3. המשך פעולה **בהתאם להוראות הקוליות** של המכשיר

4. לאחר מתן השוק החשמלי יש לבצע מיד עיסויים ללא בדיקת דופק

בין לבין! במידה ולא ממליץ על מתן שוק יש להמשיך בעיסויים.



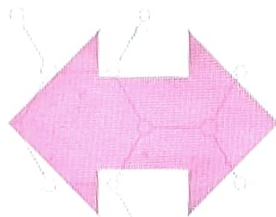
פתיחת נתיב אוויר והנשמה



01



סילוק הפרשות
ופתיחת נ"א בשיטת
מצח סנטר Head Tilt



02



ביצוע 2 הנשמות
באמצעות אמבו:
מעל שנייה ועד
עליית בית חזה

במידה ואין אמבו – אין לבצע הנשמה מפה לפה!

תפקידי הנוכח



נוכח = כל אדם אשר אינו איש רפואה המזדמן לאירוע

קריאה לעזרה - כוחות חירום

01

ביצוע עיסויים

02

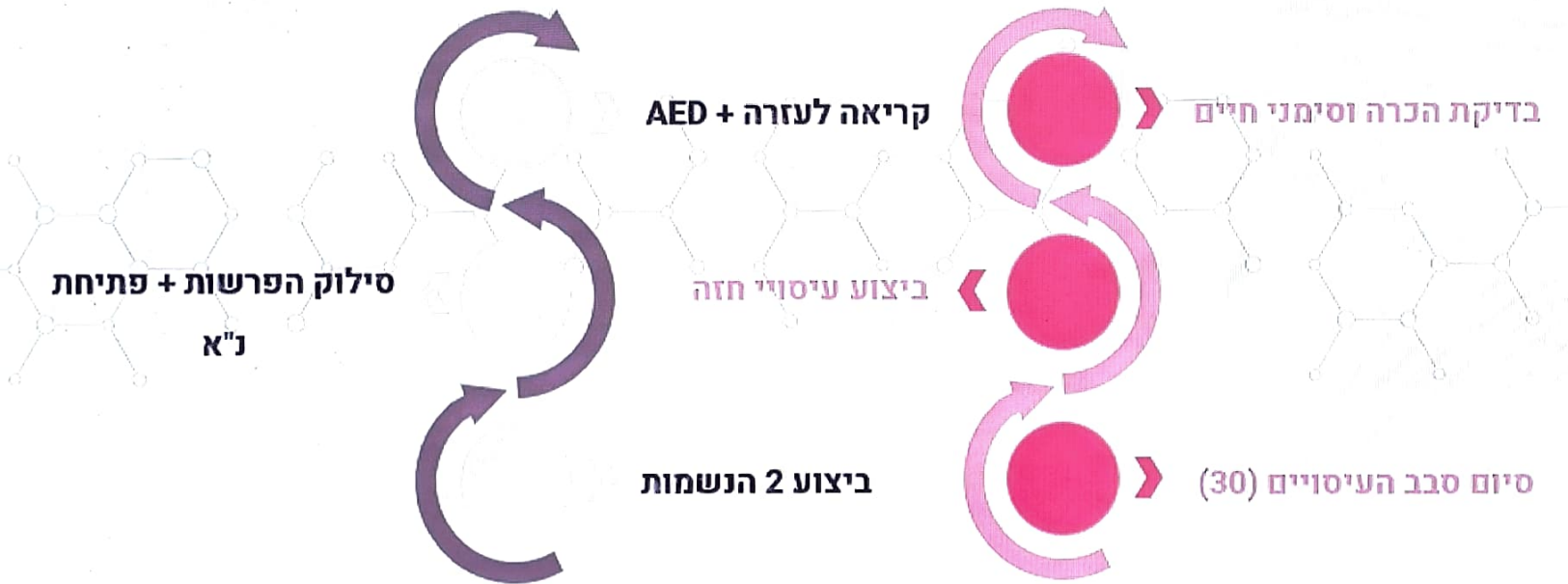
**על החובש לתת לנוכח הסברים פשוטים ולבקר את ביצועיו
במהלך הטיפול**

סכמת ההחייאה בצוות



מטפל 1 (בצד המטופל)

מטפל 2 (בראש המטופל)



החלפת מטפלים



יש להחליף בין המטפלים בכל 2 דקות! (5 סטי החיאה)

החלפה תתבצע לאחר מתן שוק/ אבחון ידני של AED בזמן שהאדם

השני מתכוון להחליף את המעסה בזמן האבחון

במידה והמעסה מתעייף באמצע האדם השני יתמקם מולו ויהיה מוכן לביצוע

עיסויים ויחליפו בספירה לאחר

החייאה מתקדמת - ALS



החייאה מתקדמת על ידי צוות עם מט"ב ותכלול:

החייאת
BLS



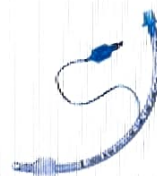
מוניטור
דפיברילטור



תרופות
החייאה



נתיב אוויר
דפיניטיבי



הפסקת החייאה



01

בעת הגעת צוות ALS

02

**כשהמטופל מתנגד
להחייאה - המטופל זז**

לא נתחיל החייאה במקרה של אובדן צלם אנוש.

במקרה זה יש ליצור קשר עם גורם אחראי לקבלת אישור לאי ביצוע החייאה

החייאה על רקע טביעה



תתבצע בסדר של:

A - פתיחת נתיב אוויר וסילוק הפרשות

B - ביצוע 2 הנשמות

C - ביצוע 30 עיסויים

יש לחבר דפיברילטור בהקדם - לייבש את בית חזה לפני הנחת המדבקות!

החייאה מוצלחת



מטופל אשר יצא מבית החולים
ללא נזק נוירולוגי משמעותי

